

WILSON GOMES	
MEDICAMENTOS:	Rivotril / Beuecar / Rosartatino (10mg) / Aldopar
SINTOMAS/QUEIXAS	HAS / Colesterol / Anemia
BANHEIRO	3X
HORA QUE ACORDA	6:30
HORA QUE DORME	22:30 - 00:00
PRATICA EXERCICIO	Fazer caminhada / Hidro
HORARIO DAS REFEIÇÕES	
CAFE:	ALMOÇO:
LANCHE:	JANTA:
08/09 - Sinusite Crônica infectada	
22 - Patologia de septo nasal c/ comp. obstrução	
- Reg. nódulo medindo 0,3 x 0,3 cm em pulmão (D), áreas de atelectasia em 1/3 inf (D).	
Colocar CPAP c/ pressão fixa e máx.	
N20 longe	
Oriento sobre o uso. — Jua	
15/09 P = 7cm H2O	
22 IAH = 0,5/lv	
M. de uso: 7h41'	
Bem adaptado Jua	
23/09 P = 7cm H2O Bem adaptado.	
22 IAH = 0,4/lv	
M. de uso: 7h40'	
Jua	
09/09 P = 7,0 cm H2O	
22 IAH = 0,4/lv	
M. de uso: 6h45'	
Compreu o CPAP Jua	
17/10 P = 7cm H2O	
22 IAH = 0,4/lv	
M. de uso: 7h40'	
Jua	
31/10 P = 7,0 cm H2O	
22 IAH = 0,5/lv	
M. de uso: 7h30'	
Bem adaptado Jua	
12/12 P = 7cm H2O	
22 IAH = 0,3	
M. de uso: 6h35'	
Bem adaptado Jua	

10/02 P = 7cm H2O s/ queixas
23 IAH = 0,3
M. de uso: 7h

Jua Cláudia

05/04
23

P = 7cmH₂O
M. de uso: 7h20'
IAH = 0,4
Fuga = 23,0 l/min.

Bem adaptado

Jua

06/06
23

P = 7,0 cmH₂O
IAH = 0,4 efer
M. de uso: 7hrs
Trocar o filtro

Jua

08/08
23

P = 7,0
IAH = 0,3
M. de uso: 7h14
Adaptou bem.

Aua

10/10
23

P = 7,0 cmH₂O
IAH = 0,5 efer
M. de uso: 6h30'
trocar o filtro na prox. consulta.

Relata estar retirando s/ ver.

Jua, cláudia

19/12
23

P = 7,0 cmH₂O
IAH = 0,3 efer
M. de uso: 6h21'
Adaptou bem, s/ queixas

Jua

21/02
24

P = 7cmH₂O
M. de uso: 6h26'
IAH = 0,3 efer

Adaptou bem, mas parou de utilizar por conta de um implante dentário.

Jua

22/04
24

P = 7cmH₂O
Fuga = 0,5 efer
M. de uso: 6h33'

Jua

29/01
25

P = 7,0 cmH₂O
IAH = 1,0
IAH = 1,0 efer
fuga = 33,2 lpm

Jua

17/07
25

P = 7cmH₂O
IAH = 0,9 efer
M. de uso: 7h10'
fuga = 56,4

Jua

Nome: WILSON GOMES
Data de Nascimento: 4-9-1942
IMC: 27,04
Sexo: Masculino
Data do exame: 14-05-2022

Peso: 80 kg
Altura: 1,72 m
Medico: DR. WILSON SALGADO FILHO
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 14-05-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 524,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 31,5 e 120,0 minutos. O tempo total de sono foi de 405,0, eficiência de 77,3% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,5%; estágio N2: 58,9%; estágio N3: 16,4%; sono REM: 21,2%. O índice de despertares foi de 17,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 16,0/hora, sendo elas 22 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 59 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e mínima de 85%, permanecendo 0,3% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 43 - 71 bpm e NREM de 43 - 73 bpm.

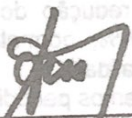
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (10), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 16,0/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=85%);
5. latência para o sono aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de atividade em EMG de queixo;
8. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (69,3/hora);
9. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado associado a distúrbio de movimento.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.





DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Wilson Gomes

EXAME nº: 5167 CPAP

SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez

DATA: 06/07/2022

IDADE: 79 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h24min e concluído às 06h10min. A latência para o sono foi de 1 minuto e a latência para o estágio REM, de 26 minutos. O tempo total de sono foi de 434,5 minutos (07h14min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 96,3%. A distribuição do sono mostrou 9,6% de estágio 1, 54,5% de estágio 2, 28,4% de estágio 3 e 7,5% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 15,5 minutos em vigília, ocorreram 83 microdespertares (Índice: 11,5/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 97,4/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 18,5/hora, sendo 1,4 apneia/hora e 17,1 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 18,5/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 95%, sendo a saturação média de 93% e a mínima de 80%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa large (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 7 cm de H₂O.

Registraram-se aumentos moderados dos índices de apneia/hipopneia (18,5/hora; índice moderado: 15 a 30/hora) e de distúrbio respiratório (18,5/hora), algumas dessaturações da oxi-hemoglobina e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 55; máxima: 66 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 1 min; normal até 30 min) – ele ingeriu um comprimido de zolpidem 10 mg às 23h10min. A latência para o estágio REM estava encurtada (26 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (96,3%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (11,5/hora; normal até 15/hora) mantiveram-se nos limites da normalidade. Houve o aumento da porcentagem do estágio 3 (28,4%; normal: 10-12%) e a redução do estágio REM (7,5%; normal: 20%). As porcentagens dos estágios 1 (9,6%; normal: 8-10%) e 2 (54,5%; normal: 45-55%) permaneceram nos limites da normalidade.

Aumento do índice de movimentos periódicos de membros (97,4/hora; índice normal até 15/hora).

Escala de Sonolência de Epworth: 12 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730



clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
PSIQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Certificação em Medicina do Sono
Sociedade Brasileira de Sono
Mestre em Psiquiatria pela UNIFESP
Doutor em Ciências pela UNIFESP
CRM-SP: 69.730

DRa. ELITÂNIA MARINHO PONTES
Medicina do Sono
Crianças e Adolescentes
CRM-SP: 62.858

Wilson Gomes

Solicito o aluguel ou venda do
(compra)
CPAP para o tratamento da síndrome da
apnéia do sono.

Ele usou a máscara nasal. Mirage
Ativa large (Resmed®).

Possibilidade de usar o unidificado.

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69.730

STC, 5/9/22

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730